OdonTeck
CONSULTING GROUP

CHECKLIST · TRAUMATOLOGÍA DENTAL

Urgencias dentales pediátricas

Qué hacer en los primeros 30 minutos ante avulsión, luxación y fractura en niños, con la diferencia clave entre dientes temporales y permanentes.

Equipo académico OdonTeck

Edición 1 · septiembre 2026

Primeros 5 minutos

> **Antes que el diente: la cabeza**
> Pérdida de conciencia, vómito, somnolencia, confusión, dolor de cabeza intenso, sangrado por nariz u oídos: **referir de inmediato a urgencias médicas**. La atención dental puede esperar.

- [ ] ¿Cómo, dónde y cuándo ocurrió? Anota la **hora exacta**: define el pronóstico de una avulsión.
- [ ] ¿El relato coincide con la lesión y la edad del niño? Lesiones repetidas o incongruentes pueden indicar maltrato: documenta y activa el protocolo correspondiente.
- [ ] ¿Esquema de vacunación antitetánica completo? Si hubo contacto con tierra y hay duda, referir al médico.
- [ ] ¿Falta un diente o un fragmento? Búscalo; si hay herida en labio con fragmento no encontrado, toma radiografía de tejidos blandos.
- [ ] ¿El diente es **temporal o permanente**? El tratamiento cambia por completo.
- [ ] Explora tejidos blandos, movilidad, desplazamiento, oclusión y toma radiografías.

Avulsión

	Diente temporal	Diente permanente
Regla principal	**No reimplantar** (riesgo de dañar el germen del permanente)	**Reimplantar lo antes posible**, idealmente en los primeros 15 minutos
Manejo del diente	—	Tomar por la corona, nunca por la raíz · si está sucio, enjuagar 10 segundos con agua fría sin tallar · reimplantar en el lugar o transportar en leche, solución salina o saliva del propio paciente (no dentro de la boca de un niño pequeño)
En el consultorio	Limpiar la herida, control del dolor, informar a los padres	Irrigar el alvéolo, reposicionar, verificar con radiografía, férula flexible por 2 semanas
Medicación	Según valoración	Antibiótico sistémico según peso y edad, y valoración antitetánica por el médico
Seguimiento	Controlar la erupción del permanente	Ápice cerrado: iniciar endodoncia a las 2 semanas · ápice abierto: vigilar revascularización

Luxaciones

Lesión	Diente temporal	Diente permanente
Concusión o subluxación	Observación, dieta blanda, higiene	Sin férula o férula flexible 2 semanas si hay movilidad marcada; control de vitalidad
Extrusión	Leve: reposicionar o dejar; severa: considerar extracción	Reposicionar y férula flexible 2 semanas
Luxación lateral	Sin interferencia oclusal: reposición espontánea · con interferencia: reposición suave o extracción	Reposicionar y férula flexible 4 semanas

Lesión	Diente temporal	Diente permanente
Intrusión	Generalmente reerupción espontánea; referir si invade el germen del permanente	Referir: según madurez radicular, reerupción, reposición ortodóncica o quirúrgica

Fracturas

Lesión	Diente temporal	Diente permanente
Esmalte	Pulir bordes	Pulir o restaurar con resina
Esmalte y dentina sin exposición pulpar	Sellar dentina con ionómero o resina	Pegar el fragmento si se conserva (hidratado) o restaurar con resina
Con exposición pulpar	Pulpotomía o extracción según edad y cooperación	Ápice inmaduro: recubrimiento o pulpotomía parcial para preservar vitalidad · ápice maduro: pulpotomía parcial o endodoncia
Fractura radicular	Fragmento coronal móvil: extraerlo y dejar el apical	Reposicionar el fragmento coronal y férula flexible 4 semanas (hasta 4 meses si es cervical)

Indicaciones para padres

- Dieta blanda de 1 a 2 semanas y evitar deportes de contacto.
- Cepillado suave después de cada comida; clorhexidina 0.12% con gasa o enjuague según edad, por 1 semana.
- Evitar chupón y biberón en lesiones de dientes temporales cuando sea posible.
- Regresar si hay dolor, inflamación, fístula o cambio de color del diente.

Calendario de controles

Tiempo	2 semanas	4 semanas	3 meses	6 meses	1 año	Anual
Qué revisar	Retiro de férula en avulsión	Retiro de férula en luxación lateral	Vitalidad y radiografía	Vitalidad y radiografía	Vitalidad y radiografía	Hasta 5 años en avulsión e intrusión

Botiquín mínimo en el consultorio
Solución salina, medio de conservación para dientes avulsionados si está disponible, alambre y resina para férula flexible, ionómero de vidrio, y el número de urgencias médicas visible.

Referencias

1. Bourguignon C, Cohenca N, Lauridsen E, et al. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 1. Fractures and luxations. Dent Traumatol. 2020;36(4):314–330.
2. Fouad AF, Abbott PV, Tsilingaridis G, et al. IADT guidelines: 2. Avulsion of permanent teeth. Dent Traumatol. 2020;36(4):331–342.
3. Day PF, Flores MT, O'Connell AC, et al. IADT guidelines: 3. Injuries in the primary dentition. Dent Traumatol. 2020;36(4):343–359.

Material de apoyo educativo para miembros del Club OdonTeck. No sustituye el juicio clínico, la valoración individual del paciente ni las guías y normas vigentes. Verifica dosis e indicaciones con la ficha técnica de cada producto.